Médecine légale
Maltraitance
Sans patient
Sans geste clinique

Nom du rédacteur : Fabienne Guena **Date de rédaction :** 01/2024

Situation de départ N° 321 Suspicion maltraitance et enfance en danger

Domaine de compétence n°1 : Synthèse des résultats d'examens paracliniques

Domaine de compétence n°2 : Stratégie de prise en charge

Attendus d'apprentissage de la situation abordée :

1 -Nourrisson, connaître les lésions associées au syndrome du bébé secoué OIC-057-05-A

2 -Connaître l'indication de l'imagerie devant une suspicion de maltraitance d'enfant

3- Connaître la sémiologie tomodensitométrique du « syndrome du bébé secoué »

4- Nourrisson, enfant, adolescent : Connaître la définition d'un signalement judiciaire, administratif et de la cellule départementale de recueil des informations préoccupantes

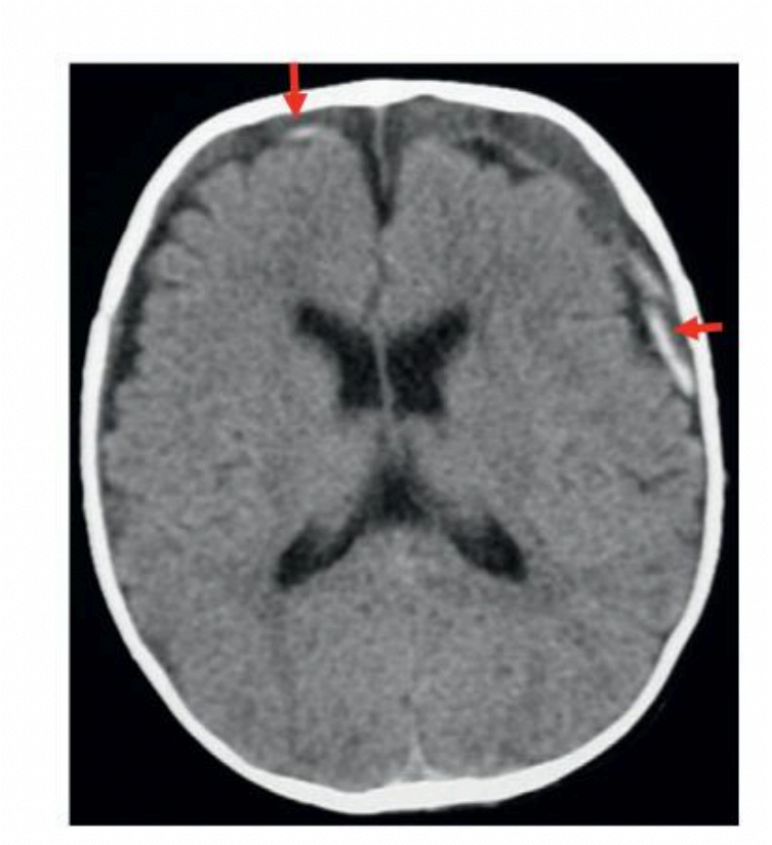
5- Maltraitance et enfants en danger : Connaître les modalités de l'orientation médicale et administrative

6- Maltraitance et enfants en danger : Connaître les modalités de la prise en charge médico légale et administrative

Patient simulé nécessaire à la station : NON

Matériel nécessaire à la station

- Mannequin NON
- Brancard NON
- Image jointe ci-dessous



Instructions à l'étudiant

Vous êtes interne aux urgences pédiatriques d'un petit CHU. L'infirmier vient vous voir concernant l'enfant Nathan, âgé de 6 mois, chez qui il suspecte un syndrome du bébé secoué, devant des pleurs inconsolables. Il est accompagné de ses deux parents qu'il suspecte être à l'origine de la maltraitance. Il n'y a pas de suspicion de sévices sexuels.

Pas de patient dans la station

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Lister 5 examens complémentaires étiologiques que vous souhaitez réaliser aux urgences/au cours de la prise en charge
2. Interpréter l'imagerie qui vous sera donnée et expliquer les signes radiologiques d'un bébé secoué à rechercher sur cet examen.
3. Détailler la prise en charge administrative de l'enfant.

Vous ne devez <u>pas</u>:

- Réaliser l'examen clinique de l'enfant, ni l'interrogatoire des parents
- Réaliser la prise en charge médicale de l'enfant

	Cocher si fait
Tache 1	
Cite comme examen supplémentaire un bilan biologique comprenant une numération formule sanguine avec plaquettes et un bilan d'hémostase	
Cite comme examen supplémentaire un scanner cérébral/ tomodensitométrie cérébrale sans injection de produits de contraste iodé	
Cite comme examen complémentaire des radiographies osseuses du squelette entier	
Cite comme examen supplémentaire une échographie abdominale	
Cite comme examen supplémentaire un fond d'oeil	
Tache 2	
Énonce qu'il s'agit d'un scanner cérébral /TDM cérébrale, en coupe axiale, en fenêtre parenchymateuse, non injecté aux produit de contraste iodé	
Énonce qu'il voit des hyperdensités spontanées fronto pariétale gauche et frontale droite, correspondant à hématome sous dural aigu (ou un saignement récent)	
Énonce que le reste de l'imagerie est sans anomalie, en particulier : *(OK si 2/3)* - Pas de lésions parenchymateuses - Pas de lésions des os crâniens Pas de lésions sous cutanées	
Cite que l'un des signes tomodensitométriques du bébé secoué au scanner est l'hématome sous dural (aigu ou chronique)	
Cite que l'un des signes tomodensitométriques du bébé secoué au scanner est l'hémorragie sous arachnoïdienne	
Cite que l'un des signes tomodensitométriques du bébé secoué au scanner est l'oedème cérébral ou alors cite l'augmentation de périmètre crânien	
Cite que l'un des signes tomodensitométriques du bébé secoué sont les hypodensités de la substance blanche correspondant à des lésions anoxiques	
Tache 3	
Énonce qu'il va hospitaliser l'enfant en urgence, si possible dans un service adapté (UAPED ou pédiatrie)	
Énonce qu'il va réaliser en urgence, à l'oral et à l'écrit, un signalement judiciaire	
Énonce la réalisation du signalement auprès du procureur de la république	
Énonce qu'il va rédiger un certificat médical initial	
COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES	
Aptitude à planifier les soins	1 à 5
Aptitude à proposer une prise en charge	

	Pondération de 1 à 5
Tache 1	
Cite comme examen supplémentaire un bilan biologique comprenant une numération formule sanguine, plaquettes et un bilan d'hémostase	1
Cite comme examen supplémentaire un scanner cérébral / tomodensitométrie cérébrale sans injection de produits de contraste iodés	1
Cite comme examen complémentaire des radiographies du squelette entier	1
Cite comme examen supplémentaire une échographie abdominale	1
Cite comme examen supplémentaire un fond d'oeil	1
Tache 2	
Énonce qu'il s'agit d'un scanner cérébral / tomodensitométrie cérébrale, en coupe axiale, en fenêtre parenchymateuse, non injecté aux produits de contraste iodés	1
Énonce qu'il voit des hyperdensités spontanées fronto pariétale gauche et frontale droite, correspondant à hématome sous dural aigu (ou un saignement récent)	1
Énonce que le reste de l'imagerie est sans anomalie, en particulier pas de lésions parenchymateuses et pas de lésions des os crâniens ou de lésions sous cutanées	1
Cite que l'un des signes tomodensitométriques du bébé secoué est l'HSD (aigu ou chronique)	1
Cite que l'un des signes tomodensitométriques du bébé secoué est l'HSA	1
Cite que l'un des signes tomodensitométriques du bébé secoué est est l'oedème cérébral ou l'augmentation de périmètre crânien	1
Cite que l'un des signes tomodensitométriques du bébé secoué sont les hypodensités de la substance blanche correspondant à des lésions anoxiques	1
Tache 3	
Énonce qu'il va hospitaliser l'enfant en urgence, si possible dans un service adapté (UAPED ou pédiatre)	1
Énonce qu'il va réaliser en urgence, à l'oral et à l'écrit, un signalement judiciaire auprès du procureur de la république	1
Énonce qu'il va rédiger un certificat médical initial	1
COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES	
Aptitude à planifier les soins	1 à 5
Aptitude à proposer une prise en charge	
NOTE TOTALE	**/25**